

إسم المريض ربيعاً : ساميه صلاح جبالي عيسي
المحافظة : الجيزه
الحى / المدينة : الاختصاص
رقم البطاقة : 27603032102121 رقم التليفون : 01118785887
العمر(تاريخ الميلاد) : 03-03-1976 المهنة : بدون عمل

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-
الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة
نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----) المقر بما فيه
التوقيع: (-----)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

GR1-E

رئيسة اللجنة
روستاق بيدي

لدى حسين
مضيف

صحة الأحياء المائية
للجنة

الاسم: د/محمد کیلانی

الاسم: د/ندی حسن

الاسم: د/نرمين رمضان

الوظيفة: ----- التوقيع:

الوظيفة: ----- التوقيع:

الوظيفة: ----- التوقيع:

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس

وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.

كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

----- / 2 ----- / 2 ----- / 2.1 ----- / 2.1

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :

خطة العلاج :

المستشفى : _____ قسم : _____

جهة العلاج : ----- نفقات :

ملاحظات :

ختم

شعار الجمهورية

مدير عام

مديرية الشؤون الصحية

رئیس

المجلس الطبي المتخصص

--

Name: ساميه صلاح جبالى عيسى National ID: 27603032102121	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



٢



٢٠٢١/٠٤

٢٧٦٠٣٠٣٢١٠٠٢١٢١

ربة منزل

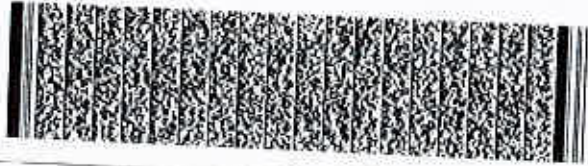
متزوجة

مسلحة

أنثى

ربيع عيده ابراهيم محمد

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٨/٠٤/٠٧



Name: ساميه صلاح جبالي		
MR. : 4882		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه The patient's tumor was documented as estrogen receptor (ER) 8/8, progesterone receptor (PR) 8/8, and HER2 negative. Multidisciplinary team discussion in February 2021 recommended adjuvant therapy consisting of four cycles of doxorubicin and cyclophosphamide (AC*4) followed by placement of a port and hormonal therapy. At the time of the note the patient was receiving letrozole (Femara) with supportive care for a planned three-month course. The record indicates that four cycles of AC have been completed. The patient continues on letrozole (Femara) with supportive care for a three-month interval, as previously prescribed in June 2023. A free ultrasound and dental consultation were arranged for the next visit scheduled for 27 October 2026.		
تحريرا في ,		
	الوقت :	التاريخ : 19-09-2026
	الطبيب المعالج : نهى سعيد علي محمد	
يعتمد ,		



وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
شرمخ، مهابقا

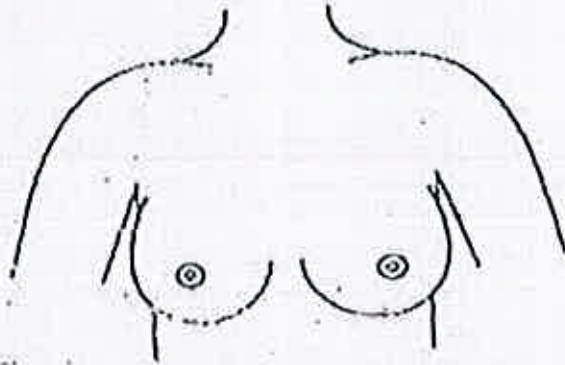
سبب المرض

0109

C-E

MDT FORM

Clinical data :



45 y.

Quadrantectomy & SLN

1/2021

Reason of discussion:

IDC GII

+ve Perinural invasion

No Vascular

MDT Outcome and Plan

Sm -ve

0/4

T2 N0

1/2/21 Pt. breast lump & lxs on 5/2/21 - pathology: IDC

PT: Nox Ho, CR 8/4 PR 8/8 Hx 2 (2x) K: 67 - 1.5
(16) (100) (17) - 5/3/11

Signature: c/c/c/c

for: Adjust ACX4. to PAX - 1.5

-femara-

MDT Form
(DOCTYPE:MDT_FORM)



Ministry of health
Central health laboratories
Pathology department

ImmunohistoChemistry report

Report Number: m6172

Female :	النوع	سامية صلاح جبالي عيسى	اسم المريض
القاهرة :	العنوان	45 Y	السن
16/11/2020 11:20 :	تاريخ استلام العينة		تاريخ اخذ العينة
17/11/2020 12:32 :	تاريخ التقرير	مركز صحة المرأة	طالب التحليل
		مركز صحة المرأة	عناية

Primary Sample :

Paraffin Block

Test :

ER & PR & HER2 neu & Ki67 (ER&PR: Harvey scoring system -Her2neu : CAP scoring system)

Comment :

Technique :

sample recieved was treated by : - CONFIRM anti-estrogen (ER) (SP1) Rabbit monoclonal primary antibody - CONFIRM anti-progesterone receptor (PR) (IE2) Rabbit monoclonal primary antibody.
Sample recieved was treated by : - VENTANA anti-HER2/neu (4B5) Rabbit monoclonal primary antibody using DAB Detection Kit in Ventana benchmark GX.
Sample recieved was treated by : - CONFIRM anti Ki67 (30-9) Rabbit monoclonal primary antibody.

Result :

ER: strong nuclear staining of 90 % of tumour cells
PR: moderate nuclear staining of 50 % of tumour cells
HER2/neu protein over expression : moderate continuous membrane staining of > 10 % of tumor cells.
Ki67 : positive nuclear staining of 1-5 % of tumour cells

Referral Lab :

Comment :

Conclusion :

ER: POSITIVE (SCORE 8/8)
PR: POSITIVE (SCORE 8/8)
HER2/NEU PROTEIN OVER EXPRESSION : EQUIVOCAL (SCORE 2+)
#Ki67: THE PROLIFERATION INDEX OF THE TUMOUR IS 1-5 %
(CORE BIOPSY)

Pathologist:

د/أيهان رمزي

Lab Director: د/تريزا ماهر

صورة طبق الأصل
16/11/2020

19 El-sheikh Rehan Street, Abdeen, Cairo
Tel (165)7948544 -7950090 Fax: (202)7948544
Mobile: 01144297292
website: <http://www.healthlabs.net>
email: pathologychl@yahoo.com
facebook: قسم الباثولوجي - الإدارة المركزية للمعامل

يتم الاحتفاظ بالعينة لمدة 30 يوم من تاريخ استلامها



ImmunohistoChemistry report

Report Number: m.6172

Female : النوع
القاهرة : العنوان
16/11/2020 14:07 : تاريخ استلام العينة
18/11/2020 12:12 : تاريخ التقرير

اسم المريض : مامييه صلاح جيهاني عيسى
العمر : 45
تاريخ اخذ العينة :
مركز صحة المرأة :
مركز صحة المرأة :
عنوان :
عنوان :
عنوان :

Primary Sample :

Paraffin Block

Test :

HER2 by ISH

Comment :

Technique :

Sample received was stained for HER2 gene and chromosome 17 using INFORM HER2 Dual Probe Cocktail technique in benchmark GX (VENTANA).

Result :

The ratio of HER2 signal to chromosome 17 in the nuclei of tumor cells is 1.7 (less than 2) indicating no amplification of HER2 gene.

Referral lab :

Comment :

Conclusion :

Referred block : HER2 GENE NOT AMPLIFIED. RATIO 1.7 (LESS THAN 2) (CORE BIOPSY)

Pathologist:

د. هادي ومزي

Lab Director: د. نورا ماهر

Patient Name: Samya Salah Jebaly.

Date: 12/6/2022

Referring physician: Prof.

^{99m}Tc -MDP BONE SCAN

Desired Information: *skeletal surveying to detect multiple lesions.*

Technique: Anterior and posterior whole-body scan performed 2 hours after I.V administration of 20 mCi ^{99m}Tc -MDP:

Report:

- Degenerative changes are noticed over Dorso-lumbar vertebrae.
- No definite hot spot that accounts for osseous deposits could be detected all over the surveyed skeleton.
- Both kidneys are normally seen.

Conclusion:

The surveyed skeleton is free of any active osseous lesions.

Thanks for referral

Nuclear Medicine Unit

DR. Sherin Makdy, MD



MULTI-SLICE CT SCAN OF THE BRAIN AFTER IV-CONTRAST ADMINISTRATION: -

Clinical History:

- o Known case of breast cancer.

Findings:

- No focal cerebral areas of abnormal density or abnormal enhancement pattern.
- Preserved normal gray-white matter interface.
- No extra-axial or intra-cerebral areas of fresh blood densities.
- Normal extra-axial CSF spaces & basal skull cisterns.
- Normal size and configuration of the ventricular system.
- No midline shift.
- Unremarkable posterior fossa structures.

OPINION:

- Normal post contrast CT study of the brain.

Dr. Ahmed M. Rozeka, MSc
Dr. M. Gomaa, M.D.



Patient Name: Samia Salah Gebali Eisa	Date : 24/10/2022
Exam : TRIPHASIC ABDOMEN & PELVIS	Age : 46 Year(s)
Medical ID:	

**MULTI-SLICE CT SCAN OF THE ABDOMEN AND PELVIS
AFTER I.V. CONTRAST ADMINISTRATION WITH
TRIPHASIC LIVER STUDY: -**

Findings:

- The liver is of average size with homogenous CT texture. Small right hepatic lobe segment VII focal lesion is seen showing peripheral nodular enhancement in the arterial phase and complete filling in the portal phase measuring about 11x10 mm.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicle dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- IUCD is seen.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both supra renals as well as pelvic organs.
- No abdominal lymph node enlargement seen.
- No ascites nor abdominal collections noted.
- Skeletal examination revealed:
 - L5/S1 1st degree degenerative spondylolisthesis.
 - L4 vertebra spinolaminectomy.
- Clear scanned lung bases.

Opinion:

- ***Small right hepatic lobe focal lesion with hemangioma pattern of enhancement.***

Dr. Ahmed M. Rozeka, MSc

Dr. Reham Anyar, FEBR, MD